

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE DIFICULTADES EN LA REGULACIÓN EMOCIONAL (DERS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Multidimensional de la Desregulación Emocional Clínica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS - Versión Española 28 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)</i>
Autores Originales	Dras. Kim L. Gratz y Lizabeth Roemer (2004), University of Massachusetts Boston.
Adaptación Española	Gonzalo Hervás y Rafael Jódar (2008), Universidad Complutense de Madrid.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Integrativo de Regulación Emocional (Gratz & Roemer).
Tipo de Instrumento	Autoinforme multidimensional de 28 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes (≥ 13 años) y adultos. Imprescindible en TLP, adicciones, TCA y trauma.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración; 10 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto para investigación académica y práctica asistencial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA DESREGULACIÓN

La DERS fue conceptualizada bajo un marco integrativo que define la regulación emocional no como el control o eliminación del afecto displacentero, sino como un constructo dinámico multidimensional que abarca: la conciencia y comprensión de las emociones, la aceptación de los estados disfóricos, la capacidad de refrenar conductas impulsivas ante el malestar y la flexibilidad para emplear estrategias moduladoras acordes a metas personales.

Neurobiológicamente, la desregulación emocional severa refleja una falla en el circuito frontolímbico: una hiperactivación fásica del complejo amigdalino y de la ínsula anterior ante estímulos de amenaza o frustración, acoplada a un reclutamiento deficiente de la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC) y del córtex cingulado anterior dorsal (dACC). Esto produce un «secuestro emocional» que precipita conductas desadaptativas urgentes (autolesiones, atracones, explosiones de ira) destinadas a reducir el afecto aversivo a cualquier precio.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (HERVÁS & JÓDAR, 2008)

Factor DERS (28 ítems)	Ítems	Rango Dir.	Operacionalización Clínica y Fenomenológica
1. Desatención Emocional	4, 6, 17, 19 (4)	4 a 20	Falta de atención consciente y desinterés hacia los propios estados afectivos corporales (ítems invertidos).
2. Confusión Emocional	16, 21, 32, 37 (4)	4 a 20	Dificultad para discriminar y rotular qué emoción específica se está experimentando en un momento dado.
3. Rechazo Emocional	3, 23, 25, 26, 35, 36 (6)	6 a 30	No aceptación del dolor psíquico: culpa, vergüenza y autorreproche secundario por sentirse mal.
4. Interferencia Cotidiana	1, 2, 22, 24, 30 (5)	5 a 25	Dificultad para concentrarse y cumplir tareas cuando se experimentan emociones negativas intensas.
5. Descontrol Emocional	5, 7, 8, 18, 20, 28, 29, 33, 34 (9)	9 a 45	Sensación de desbordamiento, creencia de que nada aliviará el dolor e impulsividad conductual.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en España: alfa de Cronbach total de 0.93 en la versión de 28 ítems (Hervás & Jódar, 2008); subescalas: Descontrol (0.91), Rechazo (0.87), Interferencia (0.85), Desatención (0.75) y Confusión (0.74).
Estructura Factorial	El AFC valida el modelo pentafactorial limpio en español, que fusionó las subescalas originales de Estrategias e Impulso en un factor único robusto de "Descontrol".
Validez Concurrente y Clínica	Correlaciones muy elevadas con gravedad del Trastorno Límite de la Personalidad, frecuencia de autolesiones no suicidas (ISAS, $r = 0.58$), depresión (BDI-II, $r = 0.62$) y alexitimia (TAS-20, $r = 0.65$).
Sensibilidad al Cambio	Medida de resultado esencial en programas de Terapia Dialéctica Conductual (DBT) y Terapia Basada en la Mentalización (MBT), mostrando tamaños de efecto d de Cohen > 0.85 postratamiento.
Invarianza de Medida	Invarianza demostrada entre adolescentes y adultos, así como entre muestras clínicas psiquiátricas y población general.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los reactivos se responde de 1 a 5 según el porcentaje de frecuencia percibida (**1** = «Casi nunca: 0–10%», **2** = «Algunas veces: 11–35%», **3** = «La mitad de las veces: 36–65%», **4** = «La mayoría de las veces: 66–90%», **5** = «Casi siempre: 91–100%»):

- **Paso 1 (Inversión de Ítems Positivos):** Invertir los ítems formulados positivamente: **1, 4, 6, 17, 19, 21, 27, 28 y 35** ($1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 1$).
- **Paso 2 (Puntuación por Factores):** Sumar los ítems de cada una de las 5 dimensiones tras la inversión.
- **Paso 3 (Puntuación Total DERS-28):** Suma de los 28 reactivos corregidos. Rango: **28 a 140 puntos**. A mayor puntuación, mayor nivel de desregulación emocional patológica.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (DERS-28)

Nivel DERS	Rango Total	Perfil Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Regulado	28 a 60	Regulación emocional adaptativa	Capacidad adecuada para experimentar y modular el afecto negativo sin conductas impulsivas.
Moderado	61 a 85	Dificultades regulatorias moderadas	Vulnerabilidad a bloqueos en metas ante estrés agudo. Psicoeducación en aceptación emocional.
Elevado	86 a 105	Desregulación clínica (corte ≥ 86)	Dificultades marcadas de autocontrol; reactividad desbordada. Indicación de entrenamiento DBT.
Severo / Extremo	106 a 140	Desregulación severa e invalidante	Crisis emocionales continuas, colapso de la conducta adaptativa y alto riesgo autolesivo o impulsivo.

ALERTA CRÍTICA: SUBESCALA DESCONTROL EMOCIONAL ≥ 30 PUNTOS:

Una puntuación en la subescala de **Descontrol Emocional ≥ 30 puntos** señala una pérdida catastrófica del control sobre los impulsos durante momentos de malestar. Es el marcador psicométrico de mayor peso para predecir tentativas de suicidio impulsivas, autolesiones no suicidas (NSSI) y conductas de purga en trastornos alimentarios.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN DESREGULACIÓN EMOCIONAL (DBT)

INTERVENCIÓN MODULAR DBT GUIADA POR EL PERFIL DERS:

- **Si Desatención y Confusión son altas (> 12 c/u):** Iniciar con el módulo de **Mindfulness**: ejercicios de observación y descripción de sensaciones sin juicio, diferenciando pensamientos de emociones primarias.
- **Si Rechazo Emocional es alto (> 18):** Foco intensivo en **Aceptación Radical** y validación emocional. Detener el reproche secundario ("no debería sentirme triste") que duplica el sufrimiento.
- **Si Descontrol e Interferencia son altos (> 28 y > 16):** Prioridad 1: **Tolerancia al Malestar**: técnicas TIP (hielo facial, relajación, ejercicio intenso) para surfear la urgencia de actuar sin empeorar la situación.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD

Paciente: Mujer de 21 años, estudiante de diseño, acude tras acudir dos veces a urgencias por cortes superficiales en antebrazos tras discusiones con su pareja. Informa que cuando se enfada o siente rechazo «su cabeza entra en un volcán que no puede apagar salvo cortándose».

Evaluación Basal DERS-28: Puntuación Total = **118 puntos** (Severidad extrema; percentil 98 clínico).

• **Subescalas:** Descontrol Emocional = **38 / 45 puntos**; Rechazo Emocional = **28 / 30 puntos**; Interferencia = **22 / 25 puntos**; Confusión = **16 / 20**; Desatención = **14 / 20**.

Formulación Clínica: Trastorno de Desregulación Emocional severo en el marco de rasgos de personalidad límite. Las autolesiones operan como una estrategia de regulación defectuosa para frenar el descontrol neurovegetativo ante el pánico al abandono.

Tratamiento DBT y Evolución: Programa DBT estándar de 24 semanas (grupo de habilidades + terapia individual). La paciente aprendió a aplicar frío intenso en muñecas y respiración diafragmática ante crisis. A los 6 meses: DERS Total se redujo a **68 puntos** (Descontrol bajó a 18; Rechazo a 14) sin nuevos episodios autolesivos en los últimos 4 meses.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO VITAL

DESCONTROL EXTREMO Y CONDUCTA SUICIDA

En pacientes con DERS Total ≥ 110 y Descontrol ≥ 35 , activar un plan de seguridad explícito para crisis. La persona carece de frenos inhibitorios ejecutivos cuando la emoción sobrepasa su umbral de tolerancia.

REGLA CRÍTICA DE INVERSIÓN

Verificar minuciosamente la inversión de los 9 ítems formulados en sentido adaptativo (ej. 1, 4, 6, 17, etc.). Omitir la inversión rebaja artificialmente el puntaje de desregulación y distorsiona el diagnóstico.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 26(1), 41–54.
2. Hervás, G., & Jódar, R. (2008). Adaptación al castellano de la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 13(3), 139–156.
3. Linehan, M. M. (1993). *Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. Guilford Press.
4. Fowler, J. C., et al. (2014). Further trade-offs in the factor structure of the Difficulties in Emotion Regulation Scale: The DERS-18 and DERS-28. *Personality and Individual Differences*, 71, 157–162.